

Налоксон

Чистый конкурентный антагонист μ -опиоидных рецепторов

ФОРМА ВЫПУСКА

0,04 % · 1 мл = **0,4 мг**
0,4 мг/мл

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Вытеснение агониста с μ -рецептора → восстановление чувствительности дыхательного центра к CO_2 . Собственной активности нет. Эффект в/в — секунды-минуты. $T_{1/2}$ 30–80 мин; клинический эффект 30–90 мин. Почти все опиоиды живут дольше → ренаркотизация.

ДОЗИРОВАНИЕ ПО АЛГОРИТМАМ

Клиническая ситуация	Доза	Путь
Опиоидная интоксикация, взрослый	0,4 мг (1 мл) ; повтор 0,4 мг	в/в
Суммарно	0,4–0,8 мг , повтор каждые 10–15 мин	в/в
Нет венозного доступа	0,4 мг в/м или 2–4 мг интраназально	в/м, и/н

Цель — ЧД $\geq 12/\text{мин}$ и SpO_2 . Не «открыл глаза», не ШКГ 15. Вводить после ДП и вентиляции, при $\text{SpO}_2 \geq 90\%$.

НАСОС 31-Р не описан; капельная инфузия ($\frac{2}{3}$ болюсной дозы в час) — стационарное решение, не линия

ОПАСНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Полная отмена у зависимого → абстиненция: рвота в незащищённые пути, катехоламиновый выброс, отёк лёгких, аритмия
- Ригидность грудной клетки (фентанил) — налоксон мышцы не расслабит; нужен НМБ
- Смешанное угнетение (этанол, бензодиазепин) — налоксон снимет только μ -компонент
- Ренаркотизация: героин — часы, метадон — сутки; эвакуация обязательна

ТАКТИКА

- Вентиляция — лечение. Налоксон — освобождение рук
- Порядок: ДП → вентиляция 100 % O_2 → $\text{SpO}_2 \geq 90\%$ → налоксон
- Международный старт: 0,04 мг, удвоение до дыхания (не строка ДЗМ)
- Наблюдение после: рвота, аускультация (отёк лёгких через 10–30 мин), ЧД, ритм